

1. La dissection de l'aorte se caractérise par une déchirure transversale de la paroi aortique.	1. Faux
2. La dissection aiguë est souvent diagnostiquée lorsque les symptômes persistent depuis plus de 14 jours.	2. Faux
3. Les dissections de type A impliquent exclusivement l'aorte ascendante.	3. Vrai
4. Les hommes sont plus prédisposés aux dissections aortiques que les femmes.	4. Vrai
5. Les personnes âgées de 70 à 80 ans sont plus sujettes aux dissections de type A.	5. Faux
6. L'hypertension artérielle est un facteur prédisposant majeur à la dissection aortique.	6. Vrai
7. Les maladies du tissu conjonctif comme le syndrome de Marfan peuvent prédisposer à la dissection aortique.	7. Vrai
8. La consommation de cocaïne est un facteur de risque pour la dissection aortique.	8. Vrai
9. La dissection aortique est parfois découverte par hasard à la tomodensitométrie thoracique.	9. Vrai
10. L'échographie transoesophagienne permet de visualiser uniquement la « vraie » lumière de la dissection.	10. Faux
11. Le traitement chirurgical est toujours nécessaire pour les dissections de type B aiguës.	11. Faux
12. La mortalité associée à la dissection de type A est de 25 % sans traitement chirurgical.	12. Faux
13. La thrombose ou l'ischémie des branches de l'aorte sont une complication de la dissection aortique chronique.	13. Faux

14. Une dilatation anévrysmale est une complication tardive de la dissection aortique.	14. Vrai
15. Le traitement endovasculaire est indiqué pour les dissections aortiques chroniques avec dilatation anévrysmale.	15. Vrai
16. Les patients présentant une dissection aortique peuvent se plaindre de douleurs abdominales aiguës.	16. Vrai
17. L'ECG ne permet pas de faire le diagnostic différentiel des douleurs thoraciques.	17. Faux
18. L'échographie externe est plus précise que l'échographie transoesophagienne pour voir la dissection aortique.	18. Faux
19. La création d'une communication entre le vrai et le faux chenal permet de traiter les dissections aortiques.	19. Vrai
20. Le traitement médical des dissections aortiques contrôle la douleur et l'hypertension artérielle.	20. Vrai
21. Un souffle diastolique d'insuffisance mitrale peut apparaître à l'auscultation d'une dissection aortique.	21. Faux
22. Les femmes sont plus prédisposées aux dissections aortiques que les hommes.	22. Faux
23. La dégénérescence physiologique de la paroi vasculaire est une cause fréquente de dissection aortique.	23. Vrai
24. Les dissections de type B affectent exclusivement l'aorte descendante.	24. Faux
25. Les personnes âgées de 40 à 50 ans sont plus sujettes aux dissections de type A.	25. Faux
26. L'exercice isométrique intense est un facteur de risque pour la dissection aortique.	26. Vrai
27. La rupture de l'adventice est une complication grave de la phase aiguë de la dissection aortique.	27. Vrai
28. Le traitement chirurgical de la dissection aortique de type B consiste à remplacer l'aorte ascendante.	28. Faux

29. Le traitement chirurgical est nécessaire pour toutes les dissections aortiques aiguës de type A.	29. Vrai
30. Les patients présentant une dissection aortique peuvent se plaindre de douleurs dorsales ou lombaires.	30. Vrai
31. L'infarctus myocardique est une complication possible de la dissection aortique.	31. Vrai
32. La dissection aortique se manifeste par une diminution symétrique des pouls périphériques.	32. Faux
33. La fenestration est une méthode de traitement endovasculaire pour les dissections aortiques de type A.	33. Faux
34. L'hémopéritoine est une complication possible de la dissection aortique.	34. Vrai
35. L'ischémie myocardique est une complication courante de la dissection aortique.	35. Vrai
36. Les dissections aortiques de type B sont plus graves que celles de type A.	36. Faux
37. La rupture de l'adventice est une complication courante de la phase chronique de la dissection aortique.	37. Faux
38. Les patients avec une dissection aortique peuvent présenter des signes d'accident vasculaire cérébral.	38. Vrai
39. L'ischémie mésentérique est une complication possible de la dissection aortique.	39. Vrai
40. L'hémorragie cérébrale est une complication possible de la dissection aortique.	40. Faux
41. La radiographie de thorax ne permet pas de diagnostiquer une dissection aortique.	41. Faux
42. La création d'une communication entre le vrai et le faux chenal est une méthode de traitement chirurgical pour les dissections aortiques de type B.	42. Faux

43. L'imagerie par résonance magnétique montre un contraste spontané entre la vraie et la fausse lumière.	43. Vrai
44. L'ischémie aiguë d'un membre est une complication possible de la dissection aortique.	44. Vrai
45. Le traitement chirurgical n'est jamais nécessaire pour les dissections aortiques chroniques.	45. Faux
46. Les hommes ont 5 fois plus de chance de développer une dissection aortique que les femmes.	46. Vrai
47. Les dissections de type A affectent exclusivement l'aorte descendante.	47. Faux
48. Les dissections aortiques de type A surviennent surtout chez les personnes âgées de moins de 40 ans.	48. Faux
49. L'échocardiographie transoesophagienne permet de visualiser uniquement la "fausse" lumière de la dissection.	49. Faux
50. La mortalité associée à la dissection de type B est plus élevée que celle de type A.	50. Faux
51. Les personnes âgées de 60 à 70 ans sont plus sujettes aux dissections de type B.	51. Vrai
52. La dégénérescence physiologique des artères et l'athérosclérose favorisent les dissections aortiques.	52. Vrai
53. La dissection aortique n'induit jamais de souffle à l'examen clinique.	53. Faux
54. Le remplacement de l'aorte ascendante est un traitement chirurgical des dissections de type A.	54. Vrai
55. La fenestration est une méthode de traitement endovasculaire pour les dissections aortiques de type B.	55. Vrai
56. La déchirure survient le plus souvent entre la partie interne de la média et l'intima en cas de dissection.	56. Faux
57. La dissection aortique est caractérisée par une déchirure longitudinale de la paroi aortique.	57. Vrai

58. On parle de dissection aortique aigue quand le diagnostic est posé <7 jours après le début des symptômes.	58. Faux
59. La fausse lumière est le plus souvent située entre la média et l'adventice.	59. Vrai
60. Le pic d'incidence pour la dissection aortique de type A survient vers 50-60 ans.	60. Vrai
61. On parle de dissection aortique chronique quand le diagnostic est posé >14 jours après le début des symptômes ou en absence de symptômes.	61. Vrai
62. La tricuspidie aortique est un facteur de risque de dissection aortique	62. Faux
63. La fin de la grossesse est une période à risque de dissection aortique.	63. Vrai
64. La canulation aortique et les traumatismes thoraciques ouverts sont à risque de dissection aortique.	64. Faux
65. La dissection peut uniquement s'étendre en amont (dissection rétrograde).	65. Faux
66. La déchirure de la paroi aortique est le plus souvent due à une poussée d'hypertension artérielle.	66. Vrai
67. Le flux à travers le « vrai » et le « faux » chenal est variable en cas de dissection aortique.	67. Vrai
68. L'insuffisance valvulaire aortique aigue est généralement bien tolérée en cas de dissection aortique.	68. Faux
69. La dissection aortique n'entraîne jamais d'ischémie viscérale.	69. Faux
70. La dissection aortique entraîne une douleur extrême progressive, spontanée et migrante.	70. Faux
71. L'insuffisance aortique aigue provoquée par la dissection aortique induit une dyspnée soudaine par OPH.	71. Vrai

72. L'examen clinique d'une dissection aortique aigue montre une hypertension artérielle de grade 2.	72. Faux
73. L'examen clinique d'une dissection aortique aigue montre une asymétrie des pouls.	73. Vrai
74. La dissection aortique peut entrainer un hemothorax droit, une tamponnade ou un choc.	74. Faux
75. La dissection aortique peut entrainer une paraplégie par une ischémie de l'artère d'Adamkiewicz.	75. Vrai
76. La dissection aortique de type B a une mortalité de 10% dans le 1 ^{er} mois.	76. Vrai
77. La dissection aortique de type A a une mortalité de 25% avec traitement et de 55% sans traitement chirurgical.	77. Vrai
78. La radiographie de thorax montre un effacement de la silhouette aortique en cas de dissection aortique.	78. Faux
79. Le CT-scanner sans injection de contraste permet de visualiser la fausse lumière en cas de dissection aortique.	79. Faux
80. L'aorto-artériographie conventionnelle est un examen invasif inutile pour la dissection aortique.	80. Faux
81. Le produit de contraste reste confiné à la vraie lumière à la tomодensitométrie d'une dissection aortique.	81. Vrai
82. Le « voile intimal » désigne la fine paroi entre la vraie et la fausse lumière de la dissection aortique.	82. Vrai
83. L'échographie transthoracique permet de visualiser une insuffisance aortique, un épanchement péricardique et le flux vers la fausse lumière en cas de dissection aortique.	83. Faux
84. Les cas de dissection aortique aigue doivent être placés sous surveillance à l'U.S.I.	84. Vrai
85. Un traitement hypotenseur IV par verapamil doit être administré en cas de dissection aortique aigue.	85. Faux

86. Le traitement hypotenseur vise à réduire la PAS sous 120mmHg et la PA moyenne à 100mmHg.	86. Faux
87. Le traitement médical de la dissection aortique aigue comprend des bêta-bloquants et de la morphine en IV.	87. Vrai
88. Toute dissection aigue de type A est une indication de chirurgie très urgente.	88. Vrai
89. Seules les dissections de type B avec ischémie sont une indication de traitement chirurgical ou endovasculaire.	89. Faux
90. La fenestration consiste à créer une communication entre le vrai et le faux chenal par voie endovasculaire.	90. Vrai
91. La revascularisation chirurgicale par pontage est une option pour les dissections de type B avec ischémie.	91. Vrai
92. La pose d'une endoprothèse couverte permet d'ouvrir la brèche intimale en cas de dissection aortique.	92. Faux
93. Les dilatations anévrysmales de l'aorte descendante doivent être opérées si leur diamètre devient >55mm.	93. Faux
94. Le diamètre anévrysmal nécessitant une intervention est plus petit en cas de maladie du tissu conjonctif (Marfan, Ehlers-Danlos,...) ou d'anomalies valvulaires mitrales congénitales.	94. Vrai
95. Les dilatations anévrysmales de l'aorte abdominale doivent être opérées si leur diamètre devient >65mm.	95. Faux
96. Les dilatations anévrysmales de l'aorte descendante doivent être opérées si leur diamètre devient >60mm.	96. Vrai
97. Les dilatations anévrysmales de l'aorte ascendante doivent être opérées si leur diamètre devient >55mm.	97. Vrai
98. Les dissections aortiques chroniques doivent être surveillées 1x/an à partir de la 3 ^{ème} année par CT ou RMN.	98. Vrai
99. Les dissections aortiques chroniques doivent être surveillées 4x/an à partir de la 2 ^{ème} année par CT ou RMN.	99. Faux

100.	Les dissections aortiques chroniques doivent être surveillées 2x/an la 1 ^{ère} année par CT ou RMN.	100. Faux
101.	Les ulcères pénétrants de l'aorte sont situés au niveau d'une plaque athéromateuse de l'aorte abdominale.	101. Faux
102.	L'ulcère pénétrant de l'aorte entraîne souvent une rupture de la limitante élastique interne.	102. Vrai
103.	L'extension de l'ulcère dans la média et au-delà peut causer un faux-anévrisme et un hématome de paroi.	103. Vrai
104.	La présentation clinique typique d'un ulcère pénétrant de l'aorte est une douleur abdominale.	104. Faux
105.	Les patients présentant un ulcère pénétrant de l'aorte sont généralement âgé et sévèrement athéromateux.	105. Vrai
106.	L'imagerie par tomodensitométrie avec contraste ou la RMN montrent un cratère ulcéreux sur la paroi vasculaire en cas d'ulcère pénétrant de l'aorte.	106. Vrai
107.	Un anévrisme de plus de 5,5 à 6 cm nécessite généralement un traitement chirurgical ou endovasculaire.	107. Vrai
108.	Le traitement chirurgical est souvent nécessaire pour les ulcères pénétrants de l'aorte ascendante.	108. Vrai
109.	Le traitement médical est toujours préféré à la chirurgie pour les ulcères pénétrants de l'aorte descendante.	109. Faux
110.	Un traitement chirurgical est envisagé pour un ulcère de l'aorte descendante si la douleur persiste.	110. Vrai
111.	Un traitement chirurgical est toujours nécessaire en cas d'ulcère aortique avec instabilité hémodynamique.	111. Vrai
112.	L'expansion de l'hémothorax est une indication chirurgicale pour l'ulcère pénétrant de l'aorte descendante.	112. Vrai
113.	Les ulcères pénétrants de l'aorte sont rarement associés à des plaques athéromateuses.	113. Faux

114. La surveillance d'un anévrisme aortique n'est nécessaire que pendant la 1ère année après le diagnostic.	114. Faux
115. Un anévrisme aortique de moins de 5,5 cm ne nécessite jamais de traitement chirurgical.	115. Faux
116. Les ulcères pénétrants de l'aorte sont généralement asymptomatiques.	116. Faux
117. Un ulcère pénétrant de l'aorte peut causer un hémothorax mais pas un hémopéritoine.	117. Vrai